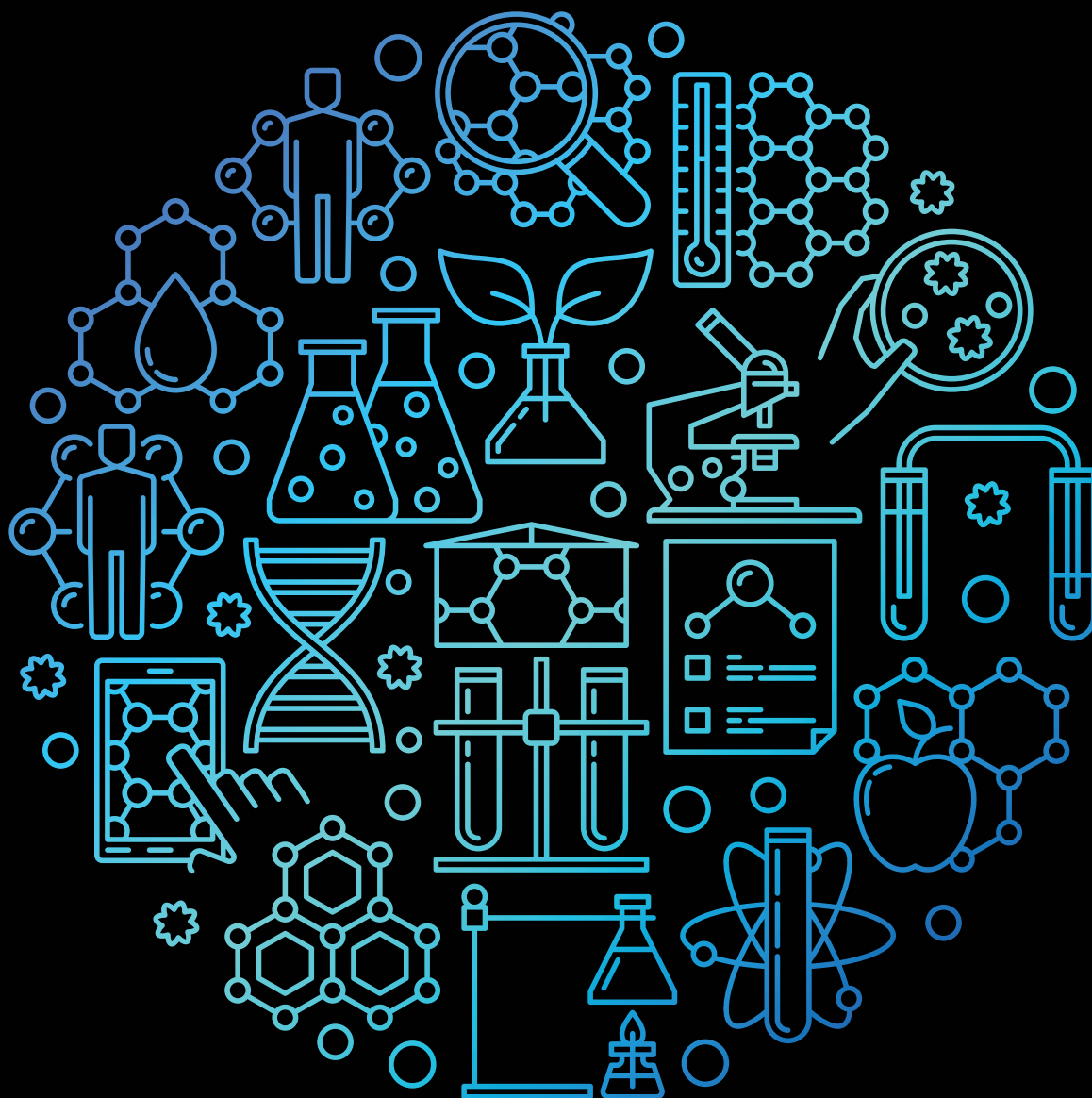




De toekomstbestendigheid van het Nederlandse Geneesmiddelensysteem

Mei 2020

Introductie

Het Nederlandse geneesmiddelenstelsel staat de laatste maanden volop in de belangstelling. De toekomstbestendigheid van het huidige stelsel, specifiek de betaalbaarheid en beschikbaarheid van (nieuwe) geneesmiddelen, wordt gezien als een van de grote uitdagingen in de Nederlandse zorg.

Er zijn al meerdere rapporten over dit onderwerp verschenen. Toch lijken we niet dichterbij een oplossing te komen, of zelfs bij een gezamenlijk beeld van de knelpunten en hun oorzaken. De discussie lijkt steeds harder en meer gepolariseerd te worden waarbij de diverse partijen in het zorglandschap van verschillende feiten — of verschillende interpretaties van de feiten — uitgaan.

Deze publicatie is het resultaat van een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het Nederlandse geneesmiddelenstelsel. Het is gebaseerd op een onderzoek dat door Deloitte is verricht in samenwerking met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Deze publicatie bevat de bevindingen en reflecties van Deloitte naar aanleiding van dit onderzoek.

Het doel van deze publicatie is niet om het perspectief van een van de partijen in het debat uit te dragen, maar juist om de verschillende perspectieven samen te brengen. Om zo, op basis van een gezamenlijke feitenbasis, te komen tot een gezamenlijk beeld van de knelpunten en hun oorzaken. Om vanuit daar verder samen te werken aan oplossingen.

Om tot dat gezamenlijk perspectief te komen, interviewden we meer dan twintig partijen in het zorgecosysteem, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorginstituut Nederland (ZIN), zorgverzekeraars, ziekenhuizen, apothekers, de farmaceutische industrie en patiënten federaties. Ook voerden we rondetafelgesprekken met een aantal van deze partijen.

Om tot de gezamenlijke feitenbasis te komen, analyseerden wij meer dan vijftig bronnen, zowel eerdere publicaties als directe databronnen.

Uit deze interviews en analyses destilleerden wij een aantal bevindingen en aanbevelingen. Wij hopen dat deze inzichten helpen een volgende stap te zetten in het waarborgen van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van innovatieve medicatie voor patiënten in de komende jaren.

Samenvatting

1. Aanleiding, aanpak, en beoogde toegevoegde waarde van dit onderzoek

1. Aanleiding: evaluatie van de toekomstbestendigheid van het Nederlandse geneesmiddelensysteem
2. Aanpak: interviews met belangrijkste stakeholders en kwantitatieve analyse, vooral gericht op betaalbaarheid en beschikbaarheid
3. Beoogde toegevoegde waarde: gezamenlijke feitenbasis, holistisch perspectief, structurering & prioritering, en eerste oplossingsrichtingen

2. Vijf belangrijkste bevindingen van dit onderzoek

1. Op dit moment presteert het Nederlandse systeem nog steeds relatief goed op betaalbaarheid en beschikbaarheid
2. Gedreven door de kostenstijging van intramurale geneesmiddelen staat de betaalbaarheid richting de toekomst wel ter discussie
3. Interventies die de betaalbaarheid beogen te borgen leiden meestal tot toenemende druk op de beschikbaarheid
4. Stijging van het volume, niet de prijzen, is de belangrijkste drijver van de druk op de betaalbaarheid
5. In de discussie over betaalbaarheid is het belangrijk zorgen over absolute betaalbaarheid, prijsvorming, en “excessen” te onderscheiden

3. Vijf fundamentele vragen op basis van deze bevindingen

1. Kunnen we de schijnbare trade off tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid doorbreken?
2. Komt druk op betaalbaarheid door te hoge kosten of te lage budgetten?
3. Wat is de juiste plek voor het (innovatieve) geneesmiddelenbudget?
4. Hoe zorgen we voor de juiste prijsvorming voor een generatie geneesmiddelen die fundamenteel anders is dan wat we kennen?
5. Hoe komen we tot een constructief zorg ecosysteem, met ook de farmaceutische partijen aan tafel?

4. Oplossingsrichtingen voor de toekomst

1. Vijf belangrijke randvoorwaarden om tot échte oplossingen te komen
2. Ingrediënten voor toekomstscenario's

5. Routekaart en vervolgstappen



1. Aanleiding, aanpak, en beoogde toegevoegde waarde

1.1 Aanleiding

Veel partijen maken zich zorgen over de toekomstbestendigheid van het huidige Nederlandse geneesmiddelensysteem, specifiek met het oog op de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Echter, een holistisch beeld ontbreekt waarin er weging en structurering van knelpunten plaatsvindt.

De hoofdvraag van dit onderzoek was: wat zijn de voornaamste knelpunten in het huidige systeem voor aanspraak, vergoeding, en bekostiging van geneesmiddelen met het oog op de toekomst? En daaruit volgend: welke gevolgen heeft dit voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen; welke aanpassingen zijn nodig voor een toekomstbestendig systeem; en wat is de beste route om die aanpassingen te realiseren?

De eerste stap hierbij is het definiëren van het Nederlandse geneesmiddelensysteem. Er bestaan inmiddels namelijk meerdere deelsystemen, elk met een eigen dynamiek.

Tot 1990 had Nederland een open en relatief overzichtelijk geneesmiddelensysteem, dat inzette op de maximale beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dit systeem vergoedde in principe alle geregistreerde geneesmiddelen, tenzij het geneesmiddel expliciet werd uitgesloten.

Echter, vanaf 1991 initieerde de overheid verschillende interventies om de betaalbaarheid van geneesmiddelen te beheersen. Significante voorbeelden zijn: de overstap naar een gesloten vergoedingssysteem via het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS), invoeren van het preferentiebeleid, de overheveling van dure geneesmiddelen, en de introductie van de sluis en financiële arrangementen.

Deze interventies zorgden voor een situatie waarin er niet één geneesmiddelensysteem meer is, maar meerdere (deel)systemen voor de toelating, pakketopname, vergoeding, en het gebruik van geneesmiddelen. Hierin zijn specifiek twee systemen te onderscheiden: het extramurale en het intramurale geneesmiddelensysteem. Extramurale geneesmiddelen worden direct gefinancierd door zorgverzekeraars op basis van de Regeling Zorgverzekering. Intramurale geneesmiddelen worden gefinancierd vanuit het ziekenhuisbudget.

De pakkettoelating van deze twee geneesmiddelensystemen verschilt. Het extramurale systeem is gesloten, waardoor geneesmiddelen alleen worden opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem na een beoordeling van ZIN en de minister van VWS. Intramurale geneesmiddelen hebben juist een automatische instroom in het basispakket.

Met de introductie van het financieel arrangement en de sluis zijn de systemen weer dichterbij elkaar gekomen. Zowel extra- als intramurale geneesmiddelen met een hoog financieel risico (hoog macrokostenbeslag of behandelkosten per patiënt) kunnen op basis van de horizonscan worden verplicht een financieel arrangement af te spreken met het ministerie van VWS om toegelaten te worden tot het pakket. Voor intramurale geneesmiddelen komt een duur geneesmiddel voorafgaand aan het financieel arrangement in de sluis. Daar toetst ZIN het geneesmiddel en worden er afspraken voor gepast gebruik gemaakt.

Bovengenoemde interventies leidde tot de observatie door enkele stakeholders dat er niet één geneesmiddelensysteem meer is, maar eerder een 'mozaïek van interventies'. Omwille van de leesbaarheid hebben we het in deze studie verder wel over "het Nederlandse geneesmiddelensysteem", waarbij we expliciet onderscheid maken tussen het extramurale en intramurale systeem. Omdat over het intramurale systeem de grootste zorgen bestaan, krijgt dat in deze studie meer aandacht.

1.2 Aanpak

Ons onderzoek is gebaseerd op een combinatie van interviews met een selectie van de belangrijkste stakeholders in het zorg ecosysteem, en analyse van eerdere publicaties en aanvullende data bronnen.

In totaal interviewden we meer dan twintig verschillende partijen in het geneesmiddelen ecosysteem. Een overzicht van de betrokken individuen en partijen is te vinden in Appendix I.

We hebben deze stakeholders bevestigd op hun visie op het huidige geneesmiddelenstelsel en waar zij in de toekomst de grootste knelpunten zien. Hierbij lag de focus op de thema's: betaalbaarheid, beschikbaarheid, transparantie, en toegevoegde waarde.

Op die vier thema's zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- **Betaalbaarheid:** totale kosten van intra- en extramurale geneesmiddelen, impact op de MSZ-zorg en Rijksbegroting, absolute prijs van individuele geneesmiddelen en kosten van geneesmiddelen per patiënt.
- **Beschikbaarheid:** registratie van geneesmiddelen en de toelating tot het pakket, de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de voorschrijver(s) en geneesmiddelentekorten.
- **Toegevoegde waarde:** de kosteneffectiviteit van individuele geneesmiddelen en de vergelijking met gerelateerde geneesmiddelen, de ketenimpact van geneesmiddelen en (alternatieve) prijsmodellen van farmaceutische bedrijven.
- **Transparantie:** de duidelijkheid van processen en prijzen van geneesmiddelen en de mate van vertrouwen tussen stakeholders.

De focus van de discussies lag dus op het stelsel van aanspraak, vergoeding en bekostiging, zowel voor extramurale als intramurale geneesmiddelen. Buiten scope waren zaken als: klinisch onderzoek, intellectueel eigendom, en voorschrijfgedrag.

Naast de interviews hebben we voor deze studie databronnen en eerdere publicaties geanalyseerd om de bevindingen uit de interviews te valideren en aan te vullen. Een gedetailleerde lijst van de geraadpleegde bronnen is te vinden in Appendix II.

Omdat uit zowel de interviews als de analyses de belangrijkste knelpunten voor de toekomst geïdentificeerd zijn rondom betaalbaarheid en beschikbaarheid van intramurale geneesmiddelen, ligt daar de nadruk op in dit verdere document.

1.3 Toegevoegde waarde van dit onderzoek

Door middel van deze studie willen we op vier gebieden waarde toevoegen aan het debat over dit onderwerp.

Allereerst willen we met deze studie een **gezamenlijke feitenbasis** creëren. Er lijkt veel discussie te zijn over feiten en cijfers; ofwel omdat partijen van andere feiten uitgaan, of omdat ze deze feiten op een andere manier interpreteren. Wij hebben zoals eerder vermeld veel van de eerdere publicaties meegenomen in onze analyses. Daarnaast hebben wij aanvullende analyses gedaan, bijvoorbeeld op basis van data uit de GIP databank. Waar nodig hebben we ook verdiepende analyses uitgevoerd, waaronder de analyse van de ontwikkeling van het aantal gebruikers en kosten per gebruiker in de periode 2014 tot 2018 van alle (>100) individuele intramurale geneesmiddelen.

Het is niet onze ambitie om van de door ons gepresenteerde feiten en cijfers de "definitieve waarheid" te maken, maar eerder om alle betrokken stakeholders die een andere interpretatie van de feiten hebben uit te nodigen tot een constructief debat waarin we wel een "gezamenlijke waarheid" kunnen vaststellen.

Daarnaast willen we komen tot een meer **holistisch systeemperspectief**. Bij dit onderzoek zijn vrijwel alle betrokken zorgpartijen geraadpleegd. Ons doel is niet om de visie van één van de partijen te verdedigen, maar juist uit te lichten waar er consensus is en waar de visies verschillen. Het doel is hierbij om de diverse partijen dicht bij elkaar te brengen, om samen tot een oplossing te komen.

Een derde toegevoegde waarde is **structurering en prioritering** van de genoemde knelpunten. In eerdere publicaties over dit onderwerp en uit de interviews zijn tientallen knelpunten naar voren gekomen; van de beschikbaarheid van bepaalde extramurale medicijnen tot de doorontwikkeling van antibiotica en de wachttijden in de sluis. Onze observatie was dat de genoemde knelpunten vaak niet van dezelfde orde waren, en dat er vaak ook sprake was van oorzaak-gevolg relaties tussen de genoemde knelpunten. Samen met de betrokken partijen hebben wij gepoogd een clustering en prioritering aan te brengen, zodat de focus kan komen te liggen op de grootste gezamenlijke knelpunten.

Als laatste hebben we, deels samen met de betrokken stakeholders, een aantal voorlopige **oplossingsrichtingen** geïdentificeerd. Dit zijn geen in detail uitgewerkte toekomstscenario's, maar wel wat eerste randvoorwaarden en kaders voor een verbetering van de toekomstbestendigheid van ons geneesmiddelenstelsel.

2. Belangrijkste bevindingen onderzoek

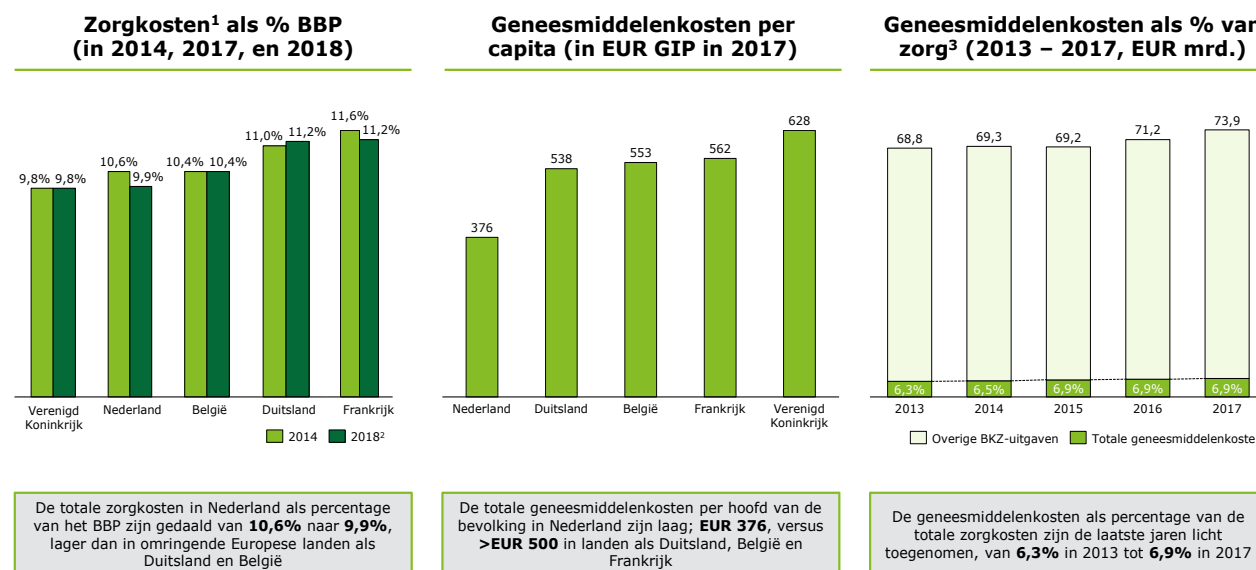
2.1 Op dit moment presteert het Nederlandse geneesmiddelenstelsel nog relatief goed

Als we afgaan op het publieke debat lijkt het alsof Nederland nu al een groot betaalbaarheidsprobleem heeft, waarbij vooral de stijgende kosten van geneesmiddelen onze zorgkosten omhoog duwen tot een onhoudbaar niveau. Echter, op dit moment lijkt Nederland nog redelijk goed te presenteren op het gebied van betaalbaarheid in vergelijking met de ons omringende landen.

Tussen 2014 en 2018 heeft Nederland de zorgkosten als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) omlaag kunnen brengen naar 9,9%. Nederland heeft daarmee, op het Verenigd Koninkrijk na, de laagste zorgkosten (als percentage van het BBP) van de vier omringende landen¹. Daarnaast heeft Nederland, ten opzichte van deze landen, de laagste uitgaven aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking².

Kijkend naar de historische ontwikkeling van geneesmiddelenkosten in Nederland, beslaan geneesmiddelen rond de 6,5% van de totale zorgkosten³. In de periode tussen 2013 en 2017 is het aandeel gestegen van 6,3% naar 6,9%.

In Figuur 1 is een vergelijking op deze verschillende onderdelen van betaalbaarheid te vinden met vier omringende West-Europese landen.



Bron: OECD, Journal of the American Medical Association, GIPellingen, GIP Databank, Rijksbegroting
 1) Alle zorgkosten, dus zowel cure als care; 2) 2018 betreft een prognose; 3) Budgettair Kader Zorg

Ook op het gebied van beschikbaarheid lijkt het Nederlandse geneesmiddelenstelsel nog relatief goed te presteren.

In Nederland zijn de meeste EMA-geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar, waarbij specifiek de beschikbaarheid van oncologie geneesmiddelen hoog is (94%). De beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen is relatief lager (71%), wat vooral het gevolg is van een ontbrekende of lage patiëntenpopulatie in Nederland.

In vergelijking met de omringende landen scoort Nederland in het midden in de tijdsduur van toegankelijkheid van geneesmiddelen.

Bij de beschikbaarheid van intramurale geneesmiddelen speelt vooral de sluisprocedure een belangrijke rol. Tussen 2015 en 2018 is het aantal intramurale geneesmiddelen in de sluis gestegen van één naar tien, waarbij de gemiddelde doorlooptijd van een intramuraal geneesmiddel in de sluis 345 dagen bedraagt.

Bij extramurale geneesmiddelen stegen de tekorten jaarlijks met ~20% per jaar tussen 2010 en 2018. Vooral de tijdelijke tekorten stegen in deze periode, de definitieve tekorten bleven relatief stabiel. Economische oorzaken liggen vooral ten grondslag aan deze definitieve tekorten; zo wordt het verdienmodel van farmaceutische bedrijven voor deze geneesmiddelen in Nederland niet langer als rendabel gezien door deze bedrijven.

¹Alle zorgkosten, dus zowel cure als care – OECD (2019)

²Journal of the American Medical Association en OECD Health Statistics (2017)

³Budgettair kader zorg, Rijksbegroting (2018)

2.2 Gedreven door de kostenstijging van intramurale geneesmiddelen staat de betaalbaarheid richting de toekomst wel ter discussie

Vrijwel alle stakeholders noemden de betaalbaarheid van intramurale geneesmiddelen als het grootste knelpunt voor de toekomst.

De genoemde knelpunten m.b.t. betaalbaarheid zijn te verdelen in twee clusters:

- Het geneesmiddelengebruik neemt toe in een mate die druk op de macro-betaalbaarheid geeft.
- De prijsstelling van geneesmiddelen lijkt, volgens een aantal stakeholders, niet houdbaar voor de toekomst.

Een belangrijke oorzaak van het toenemende geneesmiddelengebruik is de toename van de absolute hoeveelheid patiënten, onder meer door de vergrijzende populatie. Andere oorzaken zijn de toename van de hoeveelheid behandelbare indicaties — bijvoorbeeld door betere diagnostiek en toename van geneesmiddelen voor tot nu toe onbehandelbare indicaties — en een toename van de hoeveelheid geneesmiddelen per patiënt.

Er zijn drie belangrijke drijvers voor de zorgen over de houdbaarheid van de huidige prijs stelling:

Allereerst lijkt de huidige methodiek ter evaluatie van de toegevoegde waarde onhoudbaar voor een groot deel van de nieuwe geneesmiddelen. Bij bijvoorbeeld toepassing van de QALY-methodiek⁴ is gentherapie theoretisch zeer duur, door het hoge aantal extra levensjaren in goede gezondheid die een specifieke behandeling oplevert. Bij de prijsvorming wordt niet de QALY-methodiek toegepast, maar in de beoordeling wel. Door het toepassen van de QALY-methodiek mag een gentherapie theoretisch een hoge prijs hebben. Een geneesmiddel dat veel waard is, hoeft echter niet duur te zijn.

De tweede drijver is de ontoereikende transparantie en consensus over de rol van de kostprijs in de lijstprijs van geneesmiddelen. Momenteel kan prijsstelling volgens de QALY-methodiek correct zijn, maar maatschappelijk onwenselijk vanwege de relatief lagere kostprijs van het geneesmiddel. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over of en hoe de kostprijs of de investering in de prijsstelling opgenomen moet worden.

De derde drijver is dat de toegevoegde waarde tijdens de prijsstelling niet (altijd optimaal) vastgesteld kan worden, waardoor ook de lijstprijs niet optimaal wordt vastgesteld. Dit gebeurt met name bij veelbelovende producten, waarbij de resultaten van fase 2 of fase 3 onderzoek ontoereikend zijn voor een optimale inschatting van de toegevoegde waarde (op langere termijn). Gezien de eenmalige beoordeling van deze intramurale geneesmiddelen in de sluis, kan de toegevoegde waarde van deze veelbelovende producten niet volledig, en daarmee de prijs, ontoereikend vastgesteld worden.

De meerderheid van de stakeholders verwacht dat de toename van het geneesmiddelengebruik in combinatie met de prijs dynamiek leidt tot extra financiële druk op ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Uit de data-analyse blijkt inderdaad dat de betaalbaarheid meer onder druk komt, met name door de ontwikkeling van de intramurale geneesmiddelenkosten.

De kosten van extramurale geneesmiddelen als aandeel van het Budgettair Kader Zorg zijn al jaren relatief stabiel (4,1%). De kosten van deze geneesmiddelen groeien in lijn met de totale zorgkosten, en zijn op het gebied van betaalbaarheid dus niet het probleem.

De kosten van intramurale geneesmiddelen groeien echter aanzienlijk harder dan de totale zorgkosten, en vormen daarmee dus ook een steeds groter onderdeel van deze kosten. Tussen 2013 en 2017 zijn de intramurale geneesmiddelenkosten gestegen van 1,53 miljard naar 2,09 miljard (groei van 8,1% per jaar). Hierbij zijn de intramurale geneesmiddelenkosten als percentage van het Budgettair Kader Zorg gestegen van 2,2% naar 2,8%, en als percentage van de MSZ-kosten van 6,9% naar 8,9%.

⁴Quality-adjusted life year (QALY) is een begrip dat gebruikt wordt in een kostenutiliteitsanalyse (KUA), een economische beschouwing van de zin en effectiviteit van een behandeling in de gezondheidszorg. Het staat voor een extra levensjaar in goede gezondheid.

De Rijksbegroting gaat ervan uit dat de totale uitgaven aan zorg met 5,5% per jaar stijgen tussen 2019 en 2023, waarbij de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen dalen met 2% per jaar. Echter, de begroting geeft geen verduidelijking over de ontwikkeling van intramurale geneesmiddelen: deze vallen namelijk in de Rijksbegroting onder het budget van de MSZ.

Wij hebben een schatting gemaakt van de ontwikkeling van de intramurale geneesmiddelenkosten tot 2025 op basis van de doorrekening van een viertal drijvers. Deze drijvers zijn: het effect van de verwachte, te verlopen patenten; de invloed van de twintig geneesmiddelen met de hoogste budgetimpact in de huidige pijplijn (Horizonscan); de impact van de nieuwe, innovatieve geneesmiddelen (waaronder cel- en gentherapie); en de ontwikkeling van de hoeveelheid patiënten en geneesmiddelenkosten per patiënt.

Voor alle drijvers is een lage, gemiddelde, en hoge bandbreedte berekend. Op basis hiervan schatten wij dat de kosten van intramurale geneesmiddelen tussen 2019 en 2023 zullen stijgen met 0,7 miljard tot 2 miljard euro.

2.3 Interventies die de betaalbaarheid beogen te borgen leiden meestal tot toenemende druk op de beschikbaarheid

De stakeholders verwachten dat na betaalbaarheid ook beschikbaarheid een knelpunt wordt.

De druk op de betaalbaarheid van geneesmiddelen, die het gevolg is van door de overheid vastgestelde budgettaire limieten, leidt tot interventies van stakeholders in het geneesmiddelenstelsel. Voorbeelden hiervan zijn het preferentiebeleid voor extramurale geneesmiddelen en de inkoop door ziekenhuizen en verzekeraars voor intramurale geneesmiddelen.

De (gepercipieerde) druk op de betaalbaarheid van geneesmiddelen leidt ook tot interventies van overheid en zorgverzekeraars. De overheid geeft bijvoorbeeld zelf inkooparrangementen vorm middels het financieel arrangementen bureau en neemt daarmee dus de inkooprol over van andere stakeholders. Ook heeft de overheid in 2015 de sluisprocedure ingesteld voor intramurale geneesmiddelen. Meest recentelijk heeft de koepel van zorgverzekeraars (ZN) de beoordeling van alle intramurale geneesmiddelen die niet door de sluis gaan op zich genomen om de vraagprijzen te reduceren. Dit soort interventies leiden tot druk op de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Op dit moment is beschikbaarheid vooral in het extramurale stelsel een knelpunt. De stakeholders identificeren drie kernknelpunten:

- Extramurale geneesmiddelen komen met vertraging op de markt;
- Er zijn (in toenemende mate) geneesmiddelentekorten;
- Er is geen ontwikkeling van sommige, noodzakelijke, extramurale geneesmiddelen (bv. antibiotica).

De stakeholders verwachten ook druk op de beschikbaarheid van de innovatieve, intramurale geneesmiddelen, als gevolg van interventies op betaalbaarheid. Er komen naar verwachting meer middelen in de sluis, en deze middelen blijven daar ook langer.

Dat er steeds meer geneesmiddelen in de sluis komen, komt vooral door de absolute toename van nieuwe intramurale geneesmiddelen en het feit dat deze nieuwe generatie intramurale geneesmiddelen een hoger kostenbeslag heeft.

De langere doorlooptijd in de sluis heeft drie oorzaken. De toename van geneesmiddelen in de sluis zetten de huidige capaciteit van bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland en het Bureau Financiële Arrangementen onder druk. Ook de groeiende complexiteit van de nieuwe generatie geneesmiddelen — waarbij de toegevoegde waarde en de daaraan gerelateerde lijstprijs moeilijk vast te stellen zijn — drukken op deze capaciteit. Ten slotte vertragen ook operationele inefficiënties het sluisproces mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan onduidelijkheid over het aanleveren van data door farmaceutische bedrijven voor de beoordeling, door de complexiteit van sommige innovatieve middelen is het niet altijd tijdig duidelijk welke data benodigd is om tot een goede beoordeling te komen.

In onze interviews werden bovengenoemde ontwikkelingen door een aantal partijen aangeduid als “steeds meer hoepels” waar farmaceutische bedrijven doorheen moeten om hun geneesmiddel vergoed en bij de patiënt te krijgen. Deze “hoepels” zijn echter vooral ontstaan als een reactie op zorgen over de betaalbaarheid; de beschikbaarheid structureel verbeteren lijkt pas te lukken na het voeren van de betaalbaarheidsdiscussie.

2.4 Stijging van volumes, niet prijzen, is de belangrijkste drijver van de druk op de betaalbaarheid

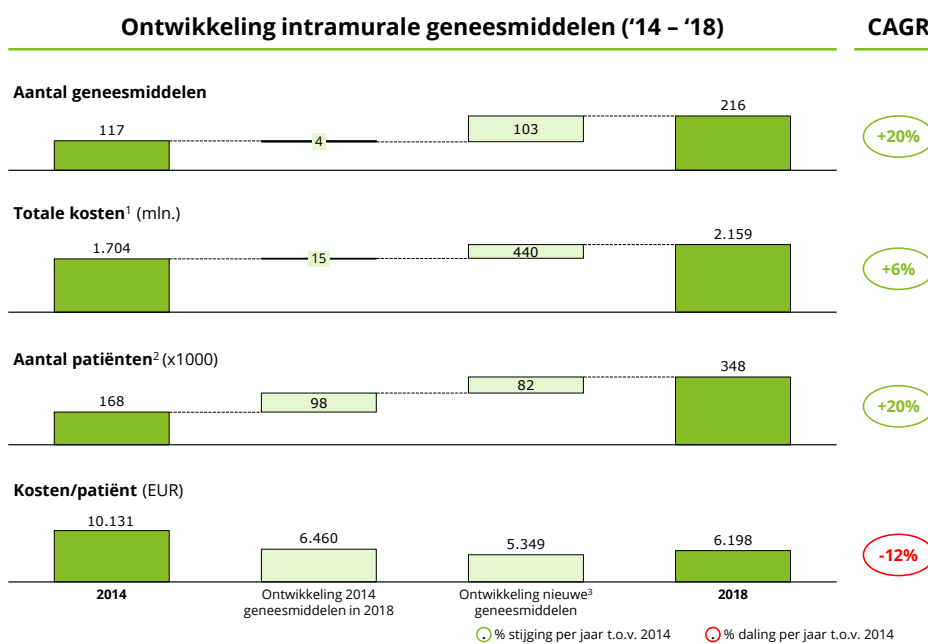
De kostenstijging van intramurale geneesmiddelen in de periode 2014-2018 wordt gedreven door een toename van de hoeveelheid patiënten, waarbij de kosten per patiënt juist significant zijn gedaald.

In de periode 2014-2018 is het aantal patiënten dat intramurale geneesmiddelen gebruikt gestegen met 20% per jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal gebruikers van geneesmiddelen die al in 2014 beschikbaar waren, maar ook door de bijkomende patiënten die gebruik maken van geneesmiddelen die na 2014 op de markt zijn gekomen.

De geneesmiddelenkosten per persoon zijn in deze periode met 12% per jaar gedaald, waarbij zowel de gemiddelde intramurale geneesmiddelenkosten per gebruiker van bestaande geneesmiddelen, als nieuwe geneesmiddelen — op de markt gekomen na 2014 — lager zijn dan de gemiddelde kosten per gebruiker in 2014.

De daling van de kosten per gebruiker in de periode 2014-2018 komt door zowel een absolute prijsdaling van geneesmiddelen als door een relatieve toename in het gebruik van goedkopere geneesmiddelen.

Figuur 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de intramurale geneesmiddelen in de periode 2014-2018. Alle onderstaande calculaties hebben op basis van GIP data plaatsgevonden, hetgeen betekent dat kortingen aan ziekenhuizen en de besparingen op grond van de financiële arrangementen hierin nog niet zijn meegenomen.



Bronnen: GIP Databank

1) Dit omvat niet de te verrekenen kosten; 2) niet unieke patiënten, aantal unieke patiënten gestegen met 16,5%; 3) op de markt gekomen tussen 2015 - 2018

De lagere intramurale geneesmiddelenkosten per patiënt in 2018 hebben we verder onderzocht door de kosten van alle individuele intramurale geneesmiddelen te analyseren.

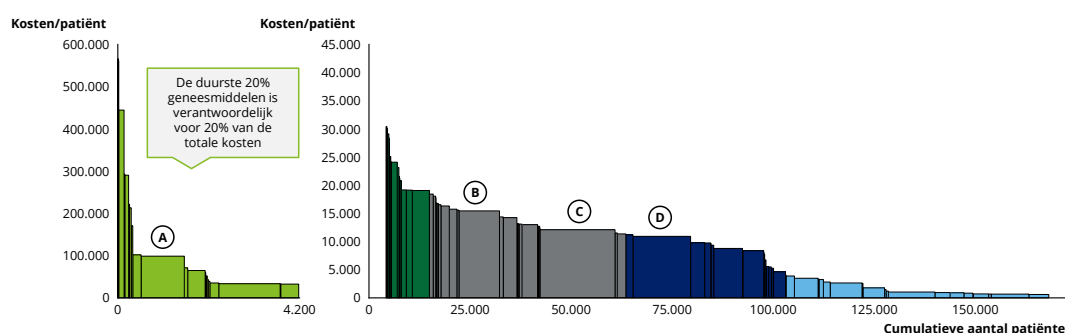
De geneesmiddelen in een bepaald jaar zijn daarbij weergegeven als een staaf, waarbij de hoogte van de staaf staat voor de kosten per patiënt en de breedte voor de hoeveelheid patiënten die dat geneesmiddel gebruikten. De intramurale geneesmiddelen zijn per geneesmiddel gerangschikt op basis van kosten per patiënt. De geneesmiddelen zijn verdeeld over vijf (ongeveer) gelijke groepen op basis van het totale aantal geneesmiddelen.

In 2014 is te zien dat geneesmiddelen die rond de 10.000 euro per jaar kosten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de intramurale geneesmiddelenkosten. Ongeveer 20% van de geneesmiddelen had een kostenbeslag van meer dan 35.000 euro per patiënt per jaar; dit deel is ook verantwoordelijk voor 20% van het totale intramurale kostenbeslag in 2014. Het duurste kwintiel geneesmiddelen qua kosten per gebruiker heeft dus geen bovengemiddelde impact op de totale kosten, omdat het aantal gebruikers van deze dure geneesmiddelen veel lager is dan van de overige intramurale geneesmiddelen.

De totale kosten van de in 2014 al beschikbare geneesmiddelen zijn ten opzichte van 2018 ongeveer gelijk gebleven: 1.704 miljoen euro ten opzichte van 1.719 miljoen euro. Het aantal patiënten dat deze geneesmiddelen gebruikt is in deze periode gestegen met 12% per jaar, maar deze groei is opgevangen door een gemiddelde prijsdaling van deze geneesmiddelen met 11%. Deze daling van de kosten per patiënt en toename van het aantal patiënten van intramurale geneesmiddelen beschikbaar in de periode 2014-2018 is zichtbaar in elk kwintiel.

Kosten per patiënt en aantal patiënten van intramurale geneesmiddelen in 2014

Voorbeelden



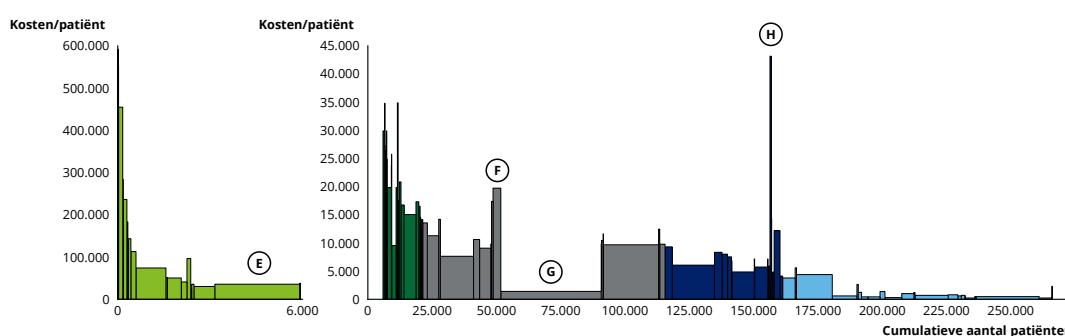
- A** Factor viii
Kostenbeslag van 98,6 mln.
- B** Infiximab
Kostenbeslag van 154 mln.
- C** Adalimumab
Kostenbeslag van 224 mln.
- D** Etanercept
Kostenbeslag van 156 mln.

Kwintiel	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	Totaal
# geneesmiddelen	23	23	23	23	25	117
# patiënten	4.182	11.687	47.699	39.521	65.134	168.223
Gem. kosten/patiënt	81.677	20.914	13.624	9.246	1.581	10.131
Kostenbeslag (mln.)	341,6	244,4	649,8	365,4	103	1.704

Bronnen: GIP Databank

Kosten per patiënt en aantal patiënten van intramurale geneesmiddelen uit 2014 in 2018

Voorbeelden



- E** Lenalidomide
Stijging van aantal patiënten met 94% t.o.v. 2014
- F** Enzalutamide
Stijging van aantal patiënten met 304% t.o.v. 2014
- G** Bevacizumab
Daling kosten/patiënt van -89% t.o.v. 2014
- H** Ibrutinib
Kosten/patiënt stijging van 603% t.o.v. 2014

Kwintiel	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	Totaal
# geneesmiddelen	22	23	22	23	23	113
# patiënten	5.924 +9%	13.858	95.732	45.823	104.826	266.163 +12%
Gem. kosten/patiënt	64.873 -6%	17.711	6.656	7.005	1.253	6.460 -11%
Kostenbeslag (mln.)	384,3 +3%	245,4	637,2	321,0	131,4	1.719 +0%

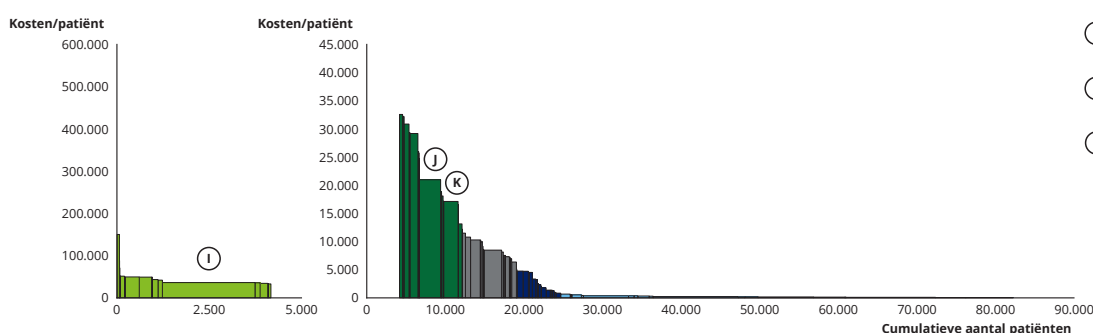
Bronnen: GIP Databank

% stijging per jaar t.o.v. 2014 % daling per jaar t.o.v. 2014

Voor de geneesmiddelen die op de markt zijn gekomen tussen 2015 en 2018, zijn de kosten per patiënt ook gemiddeld lager dan de kosten per patiënt van intramurale geneesmiddelen in 2014. Hierbij valt met name het duurste kwintiel op, waarbij de gemiddelde kosten per patiënt van het duurste kwintiel nieuwe geneesmiddelen in 2018 gemiddeld 49% lager zijn dan die van het duurste kwintiel in 2014. Daarnaast valt het op dat er in 2014 nog 11 middelen waren met gemiddelde kosten per patiënt van 100.000 euro of meer. In 2015-2018 zijn er slechts twee middelen met dergelijke hoge prijzen bij gekomen.

Kosten per patiënt en aantal patiënten van nieuwe¹ intramurale geneesmiddelen in 2018

Voorbeelden



I	Pembrolizumab Kostenbeslag van 91,2 mln.
J	Nivolumab Kostenbeslag van 56,0 mln.
K	Palbociclib Kostenbeslag van 31,4 mln.

Kwintiel	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	Totaal
# geneesmiddelen	20	21	20	21	21	103
# patiënten	4.165	7.983	6.890	5.658	57.559	82.255
Gem. kosten/patiënt	41.490	22.343	8.888	2.832	200	5.349
Kostenbeslag (mln.)	172,8	178,4	61,2	16,0	11,5	440

Bronnen: GIP Databank

1) Op de markt gekomen tussen 2015 - 2018

2.5 In de discussie over betaalbaarheid is het belangrijk zorgen over absolute betaalbaarheid, prijsvorming, en “excessen” te onderscheiden

Een belangrijk terugkerend thema in de interviews was het belang van een meer constructieve en feitelijke discussie. Opvallend was de energie over dit onderwerp en tegelijkertijd het gevoel van onmacht om de genoemde knelpunten aan te pakken.

Een verharding en polarisering in de discussie was merkbaar, specifiek over de geneesmiddelenkosten, absolute prijzen van geneesmiddelen en het verdienmodel van de farmaceutische bedrijven. Veel stakeholders ervaren een gebrek aan vertrouwen en transparantie tussen zorgpartijen, overheidspartijen en farmaceutische bedrijven.

Ook opmerkelijk is dat het in de interviews veel ging over een klein aantal geneesmiddelen, de zogenoemde excessen. Dit zijn vaak producten ontwikkeld door kleine startups, die na fase 1 of fase 2 onderzoek worden overgenomen door grote gevestigde farmaceutische bedrijven of oude producten die geregistreerd worden voor een (nieuwe) indicatie. Deze bedrijven brengen de geneesmiddelen na fase 3 en goedkeuring voor een hoge prijs op de markt en die prijs lijkt niet in verhouding te staan tot de kosten die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van het product.

Dit is op zichzelf een valide discussie, waar een goede oplossing voor moet worden gevonden. Het is echter belangrijk die discussie niet te vermengen met het grotere toekomst probleem van de betaalbaarheid van innovatieve geneesmiddelen.

Deze zogenoemde excessen hebben namelijk slechts een minieme (<1%) impact op het echte, grote probleem voor de toekomst: de verwachte kostenstijging voor intramurale geneesmiddelen. Ze leiden de discussie dus vooral af van de fundamentele knelpunten.

Voor een zuivere discussie moeten deze excessen dus geïsoleerd worden van structurele knelpunten op betaalbaarheid. De overheid en farmaceutische bedrijven zelf moeten deze excessen hard aanpakken, maar de structurele knelpunten op het gebied van betaalbaarheid moeten vervolgens het uitgangspunt van het verdere debat zijn.

We moeten dit debat op een constructieve manier voeren; met alle partijen en op basis van een gezamenlijk beeld van de feiten.

Zelfs als we de excessen buiten beschouwing laten, leidt het debat over betaalbaarheid vaak naar een discussie over “middelen met zeer hoge prijzen”. Ook hier geldt: de discussie over prijsvorming van innovatieve geneesmiddelen is een terechte, en zeker als het gaat om de zeer dure middelen met kosten van meer dan EUR 100.000 per patiënt. Maar zoals uit bovenstaande analyse blijkt, zijn deze zeer dure middelen voor een beperkt aantal patiënten niet de grootste drijver van druk op de betaalbaarheid. Dat is eerder de sterke stijging van het aantal gebruikers van middelen van rond de EUR 10.000.

Die stijging is op zichzelf niet iets slechts. Het betekent namelijk ook dat we nu meer dan ooit patiënten met complexe ziektes effectief kunnen behandelen. Het roept wel een maatschappelijke discussie op in hoeverre we de kosten van al die innovatieve medische mogelijkheden kunnen, en willen, dragen.

Samenvattend: de discussies over excessen, prijs stelling en de absolute betaalbaarheid gedreven door toename van het volume, zijn allen relevant. Voor een constructieve discussie gericht op echte oplossingen is het echter belangrijk deze drie niet door elkaar te halen.

3. Een aantal reflecties voor de toekomst

Deze vijf bevindingen leiden tot enkele fundamentele vragen. De discussie over deze vragen is te complex om in deze publicatie al een “beste antwoord” vast te stellen. Deze vragen zijn dus eerder bedoeld als een uitnodiging aan de relevante stakeholders voor verdere discussie.

3.1 Kunnen we de schijnbare trade-off tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid doorbreken?

Het grootste probleem voor de toekomst is de druk op de betaalbaarheid van intramurale geneesmiddelenkosten, die — als de historische lijn zich voortzet — dus ook leidt tot meer druk op de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen.

Maar is deze correlatie echt noodzakelijk of kunnen we deze doorbreken? Kan snellere beschikbaarheid niet juist gepaard gaan met een verbetering van de betaalbaarheid?

Een belangrijk onderdeel van de hoge geneesmiddelenprijzen zijn de hoge ontwikkelingskosten. In fase 1 en 2 zijn de investeringskosten nog relatief laag. Fase 3 onderzoek vergt echter grote kapitaalkracht. Dit leidt er in de praktijk ook vaak toe dat kleine innovatieve startups met een veelbelovend middel in deze laatste onderzoeksfase worden overgenomen door grote, gevestigde farmaceutische bedrijven.

Er zijn verschillende theorieën over het verlagen van deze kapitaalkosten. Een van de oplossingen die in ons onderzoek regelmatig genoemd werd is vereenvoudiging van het fase 3 onderzoek. Daardoor kunnen geneesmiddelen eerder ter beschikking komen van patiënten, tegen lagere kapitaalkosten. Oftewel; druk op de betaalbaarheid leidt tot druk op de beschikbaarheid, maar snellere beschikbaarheid kan leiden tot betere betaalbaarheid. Hetzelfde geldt voor oplossingen rondom “cyclisch pakketbeheer”, waarbij innovatieve geneesmiddelen eerder op de markt kunnen komen maar later worden gerevalueerd.

3.2 Komt druk op de betaalbaarheid door te hoge kosten of te lage budgetten?

Er is in de betaalbaarheid discussie veel aandacht voor prijzen en minder voor volume. De oplossing lijkt ook vooral gezocht te worden in de hoek van de farmaceutische bedrijven, in de vorm van prijs verlagingen.

Het is niet in de scope van ons onderzoek om in te gaan op het verdienmodel van farmaceutische bedrijven, en de prijzen die nodig zijn om de kapitaalkosten en rendement verwachtingen van aandeelhouders te dekken. Aangezien het hier vooral gaat om internationale, wereldwijd actieve bedrijven vragen wij ons ook af hoeveel ruimte er is voor een specifiek Nederlandse discussie over dit onderwerp.

Onze feitenanalyse wijst uit dat de fundamentele drijver van de intramurale kostenstijging in de laatste jaren de gebruikerstoename is en niet de geneesmiddelenprijs; de gemiddelde kosten per gebruiker zijn zelfs gedaald. Deze volumestijging van intramurale geneesmiddelen is dus de fundamentele oorzaak van het betaalbaarheidsknelpunt. Ook naar de toekomst toe verwachten we, ondanks de ontwikkeling van een aantal nieuwe geneesmiddelen met zeer hoge prijzen, dat de stijging van het aantal gebruikers een relatief grotere impact zal hebben dan stijging van de gemiddelde prijzen.

Deze inzichten rondom betaalbaarheid roepen een aantal fundamentele vragen op over budget versus kosten. Is er een betaalbaarheidsprobleem vanwege te hoge kosten of een te laag budget? Als de overschrijding niet het gevolg is van prijsstijging, maar van een stijging van het aantal mensen dat we behandelen, dan vraagt om een maatschappelijke discussie over hoeveel we uit willen geven aan geneesmiddelen.

Dit roept ook de vraag op of we echt (voor)bereid zijn om te betalen voor doorbraakinnovaties? Dit heeft al tot uitdagingen geleid bij bijvoorbeeld nieuwe HIV- en Hepatitis C-medicatie, en leidt momenteel bij oncolytica en in de toekomst mogelijk bij Alzheimer-medicatie tot nieuwe uitdagingen. Deze middelen hadden een gunstige kosteneffectiviteit, maar wel hoge absolute kosten, waardoor er desondanks een betaalbaarheidsprobleem ontstond, ook al had het geneesmiddel een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Een positieve kosteneffectiviteit is niet voldoende om in het huidige systeem betaalbaarheidsproblemen te voorkomen.

In de budgettering en de discussie over betaalbaarheid lijkt het in ieder geval nodig om meer aandacht te hebben voor het toenemende volume, iets dat nu onvoldoende lijkt te worden meegenomen. Het is zinvol om met alle relevante stakeholders jaarlijks een realistische volumeraming te maken, inclusief interventies rondom gepast gebruik. En een constructieve discussie hoeveel geld we willen toekennen aan het behandelen van specifieke ziektes (en individuele patiënten), en de rol daarin van medicatie versus overige zorg.

3.3 Wat is de juiste plek voor het (innovatieve) geneesmiddelenbudget?

Uit de bovenstaande bevindingen lijkt de conclusie te trekken, dat de partij die verantwoordelijk wordt gesteld voor het intramurale geneesmiddelenbudget, zeer waarschijnlijk een probleem in handen krijgt.

Het budget lijkt niet voldoende mee te groeien met de behandelopties en bijbehorende stijgende patientenvolumes. De eigenaar van dit budget moet dus rekening houden met het risico van overschrijding. Die overschrijding zal dan dus ten koste gaan van hun overige zorg budgetten.

Deze budgetoverschrijding komt nu ten laste van de overige MSZ-zorg, doordat het budget is neergelegd bij de ziekenhuizen middels het hoofdlijnakkoord MSZ. Maar is dit de beste partij om de mogelijke overschrijding te voorkomen of te dragen? Of zijn er betere alternatieven?

3.4 Hoe zorgen we voor de juiste prijsvorming voor een generatie geneesmiddelen die zo fundamenteel anders is dan wat we kennen?

Los van de absolute betaalbaarheid zijn er een aantal andere complicaties die ervoor zorgen dat de huidige methodiek voor de beoordeling en prijsvorming van de toekomstige generatie geneesmiddelen mogelijk ontoereikend is.

Cel-therapie zoals Car-T is bijvoorbeeld een moeilijk te beoordelen categorie innovatieve geneesmiddelen. Dit soort geneesmiddelen zijn onderdeel van een 'personalized-medicine' proces, een op maat gemaakte behandeling voor een individuele patiënt op basis van zijn eigen cellen en dus niet simpelweg een voorverpakte tablet, injectie of infuus.

Gentherapie maakt het mogelijk het ontstaan van ziektes te voorkomen. De behandeling van bijvoorbeeld een pasgeborene geeft een enorme gezondheidswinst en heeft mogelijk een maatschappelijke impact die het systeem niet eerder heeft moeten beoordelen.

Ook zijn de verwachte aantallen gebruikers lastiger in te schatten bij innovatieve therapieën als agnostische tumorthapie doordat de diagnostiek nog in de kinderschoenen staat.

De complexiteit, prijsvorming en dus betaalbaarheid van deze innovatieve geneesmiddelen zullen ook weer leiden tot beschikbaarheidsproblemen. Enerzijds direct, doordat de bovengenoemde complexiteit het beoordelingsproces vertraagt. Anderzijds indirect, doordat interventies om de betaalbaarheid te verbeteren leiden tot druk op beschikbaarheid.

3.5 Hoe komen we tot een constructief zorg ecosysteem, met ook de farmaceutische partijen aan tafel?

Als we het over zorgpartijen hebben maken farmaceutische bedrijven daar vaak geen (primaire) onderdeel van uit, zo blijkt ook uit deze studie. De farmaceutische bedrijven willen dat echter wel graag. Naast overheidspartijen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, apotheken en alle behandelaars hebben farmaceutische bedrijven veel invloed op de ontwikkelingen in de zorg, nieuwe diagnostiek en innovatieve behandelingen. Waarom zijn deze partijen dan geen vanzelfsprekend onderdeel van de zorg en een actief betrokken partij bij de vormgeving van de toekomst van de zorg?

Het wantrouwen tussen deze grote commerciële bedrijven en de (semi-)publieke bedrijven in de zorg lijkt de samenwerking te bemoeilijken. Daarnaast blijkt ook uit dit onderzoek dat de gepercipieerde invloed van de farmaceutische sector ervoor zorgt dat farmaceutische bedrijven vaak niet aan tafel zitten maar aan diezelfde tafel wel vaak gespreksonderwerp zijn.

Wat moeten de betrokken stakeholders doen en wat kan de farmaceutische industrie zelf doen om hier verandering in te brengen? Hoe wordt de patiënt beter van een goed werkend zorgecosysteem en waarom hebben we nog niet zo'n systeem met alle relevante partijen?

Door deze vragen te beantwoorden, met begrip voor elkaars belangen en opererend vanuit een gezamenlijke feitenbasis kunnen we een constructieve discussie voeren over de toekomst van de zorg. Als wij het hebben over de transformatie van de zorg en het nieuwe zorgsysteem, zullen alle partijen hierin nieuwe rollen op zich moeten nemen en een toekomstbestendig geneesmiddelenstelsel zal moeten aansluiten bij dit nieuwe ecosysteem en deze nieuwe rollen.

We moeten elkaars kracht benutten en bijvoorbeeld gepast gebruik van geneesmiddelen stimuleren, werken aan zorgpad optimalisatie, investeren in het verzamelen van data, en ons focussen op preventie en goede (vroegtijdige) diagnostiek. Alleen dan wordt de zorg voor patiënten beter en betaalbarer.

4. Oplossingsrichtingen voor de toekomst

4.1 Vijf belangrijke randvoorwaarden om tot échte oplossingen te komen

Door de nadruk te leggen op de volume stijging willen we niet voorbij gaan aan de discussies rondom de prijzen van innovatieve geneesmiddelen.

Zoals reeds eerder besproken dienen de zogenaamde prijs excessen te worden aangepakt, waarbij ook het zelf regulerend vermogen van de farmaceutische industrie moet worden aangesproken. Daarnaast moeten we een oplossing vinden voor de meer fundamentele uitdagingen rondom de prijsvorming van nieuwe geneesmiddelen.

Ons beeld is echter dat deze prijs discussie reeds veel aandacht heeft van de verschillende betrokkenen. De impact van de volumestijging lijkt echter in het debat onderbelicht. Dit is wel een cruciaal onderdeel van het betaalbaarheid probleem en daarmee ook van eventuele oplossingen.

Om die reden zijn onderstaande vijf randvoorwaarden vooral gericht op hoe beter om te gaan met de stijging van het gebruik van innovatieve geneesmiddelen.

In combinatie met een constructieve discussie over meer toekomstbestendige prijsvorming zou ons dat dichterbij moeten brengen bij een echt toekomstbestendig geneesmiddelenstelsel.

De eerste en belangrijkste randvoorwaarde is **gezamenlijkheid**: een gezamenlijke focus op de echte fundamentele problemen. We komen niet verder als de discussie gepolariseerd blijft, of gericht op specifieke excessen in plaats van op de onhoudbare kostenstijging door toename van het aantal patiënten. De discussie moet gevoerd worden met alle relevante partijen aan tafel, met begrip voor elkaars belangen en opererend vanuit een gezamenlijke feitenbasis.

Hierbij hoort ook een gedeeld **gevoel voor urgentie** bij alle stakeholders. Het is van belang tempo te maken om de structurele knelpunten in het huidige systeem op te lossen. De komende twaalf maanden moeten er al verschillende complexe dossiers beoordeeld worden van innovatieve geneesmiddelen waarvoor nog geen passend proces is. Discussies met vergezichten over bijvoorbeeld een Europees systeem gaan over de langere termijn en helpen dus niet om fundamentele knelpunten voor de komende jaren oplossen.

De derde randvoorwaarde is een meer realistische **jaarlijkse planning**: een realistische (budget)raming op basis van een gezamenlijke feitenbasis, met meer aandacht voor volumestijging.

De vierde randvoorwaarde is **zinnig en verantwoord gebruik van geneesmiddelen**: we moeten een politieke en medische discussie voeren over de verantwoorde inzet van geneesmiddelen in verschillende stadia van een ziekte, gerelateerd aan de (verwachte) uitkomsten van de behandeling.

De laatste randvoorwaarde is het revalueren van **de budgetverantwoordelijkheid en prikkels**. We moeten bepalen waar de verantwoordelijkheid voor het geneesmiddelenbudget idealiter ligt en welke systeemprikkels de beheersbaarheid van het budget beïnvloeden.

4.2 Ingrediënten voor toekomstscenario's

Als er aan bovenstaande vijf randvoorwaarden is voldaan, kunnen de verschillende stakeholders gezamenlijk werken aan toekomstscenario's met mogelijke alternatieven voor het huidige systeem.

Het is nu nog te vroeg om deze scenario's in detail uit werken. Er zijn uit onze gesprekken met de diverse stakeholders wel een aantal mogelijke ingrediënten voor toekomstscenario's gekomen die we hier vermelden.

Een eerste ingrediënt voor toekomstscenario's zijn de nieuwe interventies die ook al in het huidige systeem opgenomen kunnen worden om specifieke knelpunten op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van gepast gebruik en het optimaliseren van het sluisproces. Deze interventies zullen naar verwachting de fundamentele problemen rond intramurale betaalbaarheid en beschikbaarheid niet volledig oplossen. Ook is er niet altijd consensus over de interventies onder alle stakeholders.

Het tweede ingrediënt is hoe we kunnen omgaan met Real World Evidence, een meer flexibele toelating en cyclisch oftewel dynamisch pakketbeheer. Daarbij moeten complexe en dure intramurale geneesmiddelen periodiek worden gerevalueerd op basis van zowel toegevoegde waarde als volume. Ook kan dan de lijstprijs periodiek bijgesteld worden als blijkt dat de toegevoegde waarde of het volume verschilt van de initiële inschatting. Dit geeft de mogelijkheid om geneesmiddelen te revalueren op basis van de realiteit en biedt een betere risicoverdeling tussen partijen, aangezien er een minder absoluut beoordelingsmoment is. Dit legt echter druk op de partijen die de Real World Evidence moeten registreren en evalueren. Ook zal het leiden tot onzekerheid over de prijsontwikkeling van een geneesmiddel.

Een derde ingrediënt is verdere samenwerking op Europees niveau. Dit kan gerealiseerd worden door een Health Technology Assessment op Europees niveau, vergelijkbaar met de huidige registratie op EMA-niveau. Dit geeft de mogelijkheid om een grotere onderhandelingskracht te realiseren en biedt een meer consistent toelatingsproces voor nieuwe geneesmiddelen. Echter, door de afhankelijkheid van Europese samenwerking duurt deze systeemaanpassing lang. Ook neemt hiermee de beslissingskracht en invloed van Nederland op de werking en inrichting van het geneesmiddelenstelsel af.

5. Routekaart en vervolgstappen

Met deze studie hopen wij de discussie over een toekomstbestendig Nederlands geneesmiddelenstelsel een stap verder te hebben gebracht.

Er zijn richting de toekomst vele mogelijke verbeteringen aan te brengen aan ons geneesmiddelenstelsel, maar focus op de echt grote thema's is belangrijk. Er lijkt consensus te zijn dat het grootste thema om samen op te lossen de betaalbaarheid van intramurale geneesmiddelen is. De druk op die betaalbaarheid neemt in de toekomst verder toe, waardoor ook de beschikbaarheid van nieuwe innovatieve geneesmiddelen onder druk komt te staan.

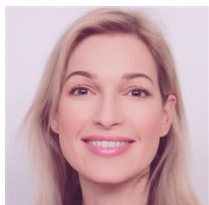
Hier is het dus belangrijk de juiste discussie te voeren, en de discussie over absolute betaalbaarheid, prijsvorming, en excessen meer uit elkaar te halen. En in de discussie over absolute betaalbaarheid zou er naast de prijzen meer aandacht moeten zijn voor de stijging van het aantal gebruikers.

Deze stijging roept ook een aantal vragen op over hoe het geneesmiddelen budget richting de toekomst vast te stellen, en wat de beste plaats is voor dit budget.

Dit zijn complexe vragen, die niet eenvoudig of eenzijdig op te lossen zijn. De belangrijkste volgende stap zou een constructieve discussie moeten zijn, met alle stakeholders aan tafel, op basis van een gezamenlijk beeld van de feiten, en begrip en respect voor elkaars belangen. Bijvoorbeeld via een serie van ronde tafel discussies in de komende maanden.

Die verdere discussie zien wij met vertrouwen tegemoet. In de totstandkoming van deze studie bespeurden wij namelijk bij alle stakeholders veel bevoegdheid over dit onderwerp. Alle partijen willen een toekomstbestendig geneesmiddelenstelsel om er zo voor te zorgen dat patiënten ook in de toekomst de zorg krijgen die ze verdienen. Samenwerking tussen alle partijen is daarbij essentieel en verdient prioriteit te krijgen op de agenda van de betrokken stakeholders.

Contact informatie



Nicole Lentink

Senior Manager Monitor Deloitte
nlentink@deloitte.nl
0654318587



John Luijs

Partner Monitor Deloitte
jluijs@deloitte.nl
0682967815



John de Kok

Partner Risk Advisory Deloitte
johndekok@deloitte.nl
0655152105



Jan-Luuk de Groot

Associate Director Deloitte
jadegroot@deloitte.nl
0615055547

Appendix 1: Overzicht geïnterviewde personen

Naam	Bedrijf	Rol stakeholder
Michel van Agthoven	Janssen	Director Patient Access & Governmental Affairs
Ad Antonisse	AstraZeneca	Directeur Market Access & External Affairs
John van Beek	GSK	Director Corporate Affairs
Geert Clement	Bayer	Head Market Access & Stakeholder Management
Ulrike Jacobi	Amgen	External affairs lead
Edwin Ket	BMS	Director Market Access
Peter Spoorendonk	Abbvie	Director Market Access
Caroline Hofste	Novartis	Head Market Access
Guido van den Boom	Roche	Chief Sustainability Officer
Linda van Saase	ZIN	Manager
Maarten Postma	UMCG/RUG	Hoogleraar Farmacie
Xander Koolman	VU	Associate professor faculty Health Economics
Jan Benedictus	NFP	Programma manager
Pauline Evers	NFK	Belangenbehartiger Geneesmiddelen
Eric Janson	KNMP	Directeur
Gerben Klein Nulent	KNMP	Voorzitter
Belinda van de Lagemaat	NFU	Senior Adviseur
Alex Verhoeven	NFU	Senior Adviseur
Rene van Duuren	ZN	Programma manager Dure Geneesmiddelen
Johan van Zeelst	VGZ	Manager Zorginkoop Farmacie
Gerard Adelaar	Zilveren Kruis	Beleidsontwikkelaar Strategie
Alexander Bybau	Zilveren Kruis	Manager Inkoopstrategie
Bas van den Dungen	Min VWS	Directeur-Generaal Curatieve Zorg
Marcel van Raaij	Min VWS	Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie
Mark van Houdenhoven	SMK	Voorzitter RvB
Ernst Kuipers	ErasmusMC	Voorzitter RvB
Floor Haak	Noord West groep	Lid RvB

Appendix 2: Overzicht geraadpleegde bronnen

- Monitor geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg; Nederlandse Zorgautoriteit (december, 2017)
- Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg; Nederlandse Zorgautoriteit (januari, 2019)
- Ontwikkelingen genees- en hulpmiddelengebruik 2013 – 2017, raming 2018 – 2022; GIP / Zorginstituut Nederland (GIPeilingen; februari, 2019)
- Ontwikkelingen genees- en hulpmiddelengebruik 2012 – 2016, raming 2017 – 2021; GIP / Zorginstituut Nederland (GIPeilingen; maart, 2018)
- Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk; Zorginstituut Nederland (November, 2018)
- Voortgangsbrief financiële arrangementen; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (oktober, 2018)
- Monitor MS-geneesmiddelen 2019; Zorginstituut Nederland (juni, 2019)
- Rijksbegroting 2019; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (september, 2018)
- Verandering voor kosten medicijnen in basispakket; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (januari, 2019)
- Verslag Vergadering Adviescommissie Pakket; Zorginstituut Nederland (oktober, 2017)
- Zorgevaluatie en Gepast Gebruik; Zorginstituut Nederland (december, 2017)
- Uitwerking maatregelen uit het Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (juni, 2018)
- Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen; BS Health Consultancy (maart, 2019)
- Effecten van het preferentiebeleid op beschikbaarheid van geneesmiddelen; Berenschot (januari, 2018)
- Medicijn Monitor 2019-2020, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (2019)
- Medicijn Monitor Editie 2019; Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (2018)
- Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022; NVZ, NFU, PF, ZKN, FMS, ZN, V&VN en VWS (juni, 2018)
- Hoofdpijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (juni, 2018)
- Pakketbeheer weesgeneesmiddelen; Zorginstituut Nederland (oktober, 2015)
- Innovatief, betaalbaar, toegankelijk: gezamenlijk op weg naar een toekomstbestendig model voor geneesmiddelenontwikkeling; License to Heal (mei, 2019)
- Bevolkingsprognose 2016 – 2060; Centraal Bureau voor Statistiek (december, 2017)
- 2019 Global health care outlook; Deloitte (2019)
- Patient access to innovatieve medicines in Europe; Deloitte (januari, 2019)
- Personalized medicine report; Personalized Medicine Coalition (2017)
- State of Health Netherlands; Europese commissie (2019)
- Pharma Innovation and Access to Medicine; OECD (2018)
- Health at a glance; OECD (2018)
- Advies regeldruk geneesmiddelen; Actal (2015)
- Ontschotting in de zorg; SiRM (2018)
- Patient W.A.I.T. indicator; EFPIA (2019)
- Drug reimbursement systems: international comparison; KCE (2019)
- A new future for R&D in pharma; Deloitte (2018)
- Making outcome-based payment a reality in the NHS; Cole et al. (2019)
- Medicines reimbursement policies in Europe; WHO (2018)
- The cost of opportunity; Gupta strategists (2019)
- Ex durante evaluatie geneesmiddelenbeleid Schippers; SiRM (2019)
- Business of regeneratieve geneesmiddelen; Alliance for regenerative medicine (juli, 2019)
- Market prognosis Netherlands; IQVIA (2019)
- Rapportage meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten 2018; VWS (2019)
- Description of the Dutch regulatory framework for pricing, reimbursement and funding of pharmaceutical products; Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (2019)
- Healthcare spending in the United States and other high-income countries; JAMA (2018)
- Data GIPdatabank (website, 2019)
- Data SFK (website, 2019)
- Data OECD (website, 2019)
- Data Staat van Volksgezondheid en Zorg (website, 2018)
- Data Horizonscan (website, 2019)
- Data VWS (website, 2019)
- Data KNMP (website, 2019)
- Data Vektis (website, 2019)
- Data ZIN (website, 2019)



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 264,000 people make an impact that matters at www.deloitte.nl.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.